

 CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ POLE MERE- FEMME	PRISE EN CHARGE DU SYNDROME D'HYPERSTIMULATION OVARIENNE		090 GYN 210 PTXX 007 Version 1 Page 1 / 5
	PROTOCOLE	GYNÉCOLOGIE	

I) CONCERNE :

- Service de gynécologie
- Service des urgences gynécologiques
- Service d'assistance médicale à la procréation

II) EPIDÉMIOLOGIE :

Le syndrome d'hyperstimulation ovarienne (HSSO) est une complication qui concerne **3 à 7% des stimulations ovariennes**, jusqu'à 20% chez les patientes à risque.

La forme sévère concerne 0.1 à 1% des femmes ayant eu une stimulation ovarienne.

Facteurs de risque de survenue :

- Terrain à risque : **femmes $\leq$ 30 ans, faible IMC, SOPK, AMH > 3 ng/mL, hypothyroïdie**
- Y-a-t-il eu un déclenchement de l'ovulation avec de l'Ovitrelle ou du Décapeptyl : **risque quasi nul si déclenchement au Décapeptyl**
- Combien d'ovocytes prélevés à la ponction : **risque plus important à partir de 20 ovocytes prélevés**
- Y-a-t-il eu un transfert d'embryon ? : **risque plus important en cas de début de grossesse associé**
- Existe-t-il des facteurs de risques associées de TVP/EP ? d'insuffisance rénale : **terrain à risque de complications de l'HSSO**

On parle de HSSO précoce en cas de survenue dans la semaine qui suit la ponction, et d'HSSO tardif en cas de survenue > 7 jours après la ponction.

III) APPLICATION :

1. SÉMIOLOGIE CLINIQUE

Signes fonctionnels devant faire suspecter le diagnostic :

- Douleurs abdominales dans X% des cas
- Nausées et/ou vomissements
- Ballonnements
- Troubles du transit
- Diurèse diminuée, urines foncées

Signes fonctionnels devant faire évoquer une potentiel complication ?

- Dyspnée
- Douleur thoracique
- Douleur dans les jambes

Intitulé et référence du document associé : aucun			
REDACTION : 01/05/2025 Dr Alicia CAROFF Chef de clinique - Gynécologie obstétrique Signé	VERIFICATION : 18/03/2026 Mohcine AICH Qualiticien - DAJPAQ Signé	VALIDATION : Dr Florence SCHEFFLER Médecin - Gynécologie obstétrique Signé	APPROBATION : Pr Nicolas MOTTET Chef de pôle mère-femme Signé
Liste de diffusion : gynécologie, urgences via le logiciel institutionnel de gestion documentaire et le classeur virtuel de Gynécologie.			
Relecture périodique du document - sans modification par :		le :	

Evaluation clinique

- Mesure du poids : prise de poids ?
- Mesure du périmètre abdominal
- Prise de constantes (saturation, FC, TA, T°C)
- Palpation abdominale
- Auscultation cardio-pulmonaire

2. INDICATION D'EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

Échographie pelvienne sus-pubienne et/ou endovaginale :

- Localisation et évolutivité de la grossesse si terme permettant de le visualiser.
- Permet l'évaluation des épanchements : douglas, espace vésico-utérin, péri-ovarien. Notifier la présence/absence d'épanchement, le quantifier (léger, modéré, abondant), noter le plus grand axe pour suivre l'évolution.
- Taille des ovaires : dans les 2 axes, kystes => **ATTENTION au risque de torsion**

Echographie abdominale +/- pleurale :

- Permet l'évaluation des épanchements : gouttières pariéto-coliques, espace inter-hépatique-rénale, plèvre. Notifier la présence/absence d'épanchement, le quantifier (léger, modéré, abondant), noter le plus grand axe pour suivre l'évolution.

Bilan biologique :

- NFS, Plaquettes
- Ionogramme sanguin, urée, créatininémie
- Albuminémie
- Bilan hépatique
- +/- bHCG si $\geq$ J14 de la ponction folliculaire (pas avant, risque de faux positif avec l'hCG utilisé pour le déclenchement de l'ovulation)

Tableau 1 Classification des syndromes d'hyperstimulation ovarienne à partir de la classification de Humaidan et al. et du « Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine ».
Ovarian hyperstimulation syndrome classification among Humaidan et al. and the "Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine".

OHSS	Forme légère	Forme modérée	Forme sévère
Douleur abdominale	Faible ou gêne	Modérées	Le plus souvent intenses
Nausées vomissements	±	±	±
Diarrhées	±	±	±
Ascite sous tension	Absence cliniquement	Non	Oui
Oligoanurie	Non	Non	Oui
Dyspnée	Non	±	Oui
Hyperleucocytose/mm ³	Inférieure à 15 000	Entre 15 et 25 000	Supérieure à 25 000
Hématocrite	< 45 %	45–55 %	> 55 %
Cytolyse hépatique	Non	±	Oui
Hyponatrémie	Non	Non	Oui
Hyperkaliémie	Non	Non	> 5 mmol/l
Ascite à l'échographie	Limitée au cul de sac de douglas	Dépasse l'utérus	Présente dans la loge de Morrison
Taille des ovaires	9–12 cm	> 12 cm	> 12 cm
Épanchement pleural	Non	Non	Oui

 CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ POLE MERE- FEMME	PRISE EN CHARGE DU SYNDROME D'HYPERSTIMULATION OVARIENNE		090 GYN 210 PTXX 007 Version 1 Page 3 / 5
	PROTOCOLE	GYNÉCOLOGIE	

Si dyspnée : associer radio pulmonaire +/- gaz du sang et D-Dimères/BNP

Si douleur thoracique : associer radio pulmonaire, ECG +/- troponine et D-Dimères/BNP

3. PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE

Traitements :

- Repos non strict
- **PAS DE RESTRICTION HYDRIQUE** : quantité libre, préférer boissons hypertoniques (Eau Vichy, Contrex, Coca Cola sans sucre ...)
- Antalgiques :
 - Paracétamol 1g x4 /jour
 - Spasfon 160 mg x3 /jour
 - Eviter les AINS (risque rénal)
 - Si insuffisant : Acupan 1 ampoule de 20 mg toutes les 8h PO (attention au risque de majoration de la constipation avec le Doliprane Codéiné et le Tramadol)
- Traitements symptomatiques :
 - Métoclopramide 10mg x3/jour si nausées ou vomissements
 - Macrogol 1-2 sachets par jour si constipation
 - Trimebutine 100mg x3/jour si inconfort abdominal, ballonnements
- Poursuivre le traitement PROGESTAN 100 mg : 1 capsule par voie vaginale matin et soir (valable si un transfert embryonnaire est prévu ou a eu lieu)
- Prévention des troubles thrombo-emboliques :
 - Bas de contention classe II en systématique (même forme légère)
 - Héparinothérapie préventive* dès la forme modérée
 - Pendant 6 semaines en l'absence de grossesse
 - Pendant tout le 1^{er} trimestre si grossesse
 - Avec surveillance plaquettaire 1/semaine
 - Relai HNF si insuffisance rénale !

*HÉPARINOTHÉRAPIE PRÉVENTIVE : ADAPTATION AU POIDS

< 50 kg : LOVENOX 2000 UI – FRAGMINE 2500 UI – INNOHEP 3500 UI /24h
50-100 kg : LOVENOX 4000 UI – FRAGMINE 5000 UI – INNOHEP 4500 UI /24h
100-130 kg : LOVENOX 6000 UI – FRAGMINE 7500 UI – INNOHEP 7000 UI /24h
> 130 kg : LOVENOX 8000 UI – FRAGMINE 10 000 UI – INNOHEP 9000 UI /24h

 CHU BESANCON FRANCHE-COMTÉ POLE MERE- FEMME	PRISE EN CHARGE DU SYNDROME D'HYPERSTIMULATION OVARIENNE		090 GYN 210 PTXX 007 Version 1 Page 4 / 5
	PROTOCOLE	GYNÉCOLOGIE	

Surveillance :

- **Rythme** : Toutes les 48h au début puis 2/semaine dès amélioration
- **Signes fonctionnels** : douleurs abdominales, nausées, vomissements, ballonnements, troubles du transit, douleur thoracique, dyspnée ...
- **Signes cliniques** : poids, périmètre abdominal, oedèmes, palpation abdominale, auscultation cardio-pulmonaire, constantes, diurèse
- **Echographie abdomino-pelvienne** : surveillance des épanchements, de la taille des ovaires
- **Bilan** : NFS, Plaquettes, ionogramme sanguin, urée, créat, protidémie, albuminémie, bilan hépatique +/- bHCG à partir de J14 post ponction.

Prévenir la PMA :

- En journée : par téléphone en appelant la CCA (32654), l'interne (14678), ou le Dr Junior (18383)
- La nuit : par mail à amp-interne@chu-besancon.fr

4. CRITÈRES D'HOSPITALISATION

Hospitalisation des formes sévères et des formes modérées mal tolérées (douleurs non soulagées par antalgiques simples/intolérance alimentaire et/ou digestive)

5. ADMISSION EN GYNÉCOLOGIE

- Mesure du poids : prise de poids ?
- Mesure du périmètre abdominal
- Prise de constantes (saturation, FC, TA, T°C)

6. EN SORTIE D'HOSPITALISATION

- Relai per os des antalgiques et traitements symptomatiques prescrits pendant l'hospitalisation
- Bas de contention classe II en systématique pendant 6 semaines en l'absence de grossesse et pendant 3 mois si grossesse
- Héparinothérapie préventive à poursuivre
 - Pendant 6 semaines en l'absence de grossesse
 - Pendant tout le 1^{er} trimestre si grossesse
- Repos non strict
- Poursuivre hydratation libre et régime hyperprotéiné jusqu'à disparition des symptômes
- Poursuivre le traitement progestatif s'il y a eu un transfert d'embryon +++

Prévenir la PMA :

- En journée : par téléphone en appelant la CCA (32654), l'interne (14678), le Dr Junior (18383)
- La nuit : par mail à amp-interne@chu-besancon.fr

 CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ POLE MERE- FEMME	PRISE EN CHARGE DU SYNDROME D'HYPERSTIMULATION OVARIENNE		090 GYN 210 PTXX 007 Version 1 Page 5 / 5
	PROTOCOLE	GYNÉCOLOGIE	

7. EN RÉSUMÉ

HSSO	Prise en charge	Surveillance	Traitements
Légère	Ambulatoire	Bi-hebdomadaire jusqu'à amélioration	Antalgiques Bas de contention Hydratation libre Régime hyperprotéiné
Modérée	Ambulatoire +/- H° de courte durée	Poids et diurèse 1/jour Bilan bio 2/sem Echographie 2/sem	Hydratation libre Régime hyperprotéiné Antalgiques Traitement symptomatique Bas de contention +/- HBPM préventif pdt 6 sem
Sévère	Hospitalisation +/- soins intensifs	Surveillance rapprochée Poids et diurèse 1/jour Bilan bio 2/sem Echographie 2/sem	Remplissage vasculaire HBPM préventive +/- Corticoïdes IV +/- Albumine IV

8. RÉFÉRENCES

[Prevention of moderate and severe ovarian hyperstimulation syndrome: a guideline](#)

[The Ovarian Hyperstimulation Syndrome - ScienceDirect](#)

[Factors Associated with Ovarian Hyperstimulation Syndrome \(OHSS\) Severity in Women With Polycystic Ovary Syndrome Undergoing IVF/ICSI - PMC](#)